

Salute Mentale — Panoramica completa

Semestre 02 · 13 lezioni

Un viaggio che parte dalle definizioni base — cos'è salute, malattia, normalità — e arriva al cuore della clinica: come si guarda, si ascolta, si comprende chi soffre. In mezzo: la storia della follia, le emozioni e le difese, i grandi quadri clinici dalle nevrosi alle psicosi, e poi il corpo in tutte le sue declinazioni — sessuato, deformato, silenzioso, violato. Il filo rosso è sempre lo stesso: l'incontro tra due persone, non la classificazione di un oggetto.

Mappa dei temi

#	Lezione	Tema centrale
01	Intro al modulo	Salute, benessere, normalità, cura vs. guarigione
02	Storia della follia	Paradigmi storici: organico vs. passionale
03	Le empatie	Empatia come costrutto multi-componente ed evolutivo
04	Dalla paura alle difese	Filiera emotiva e meccanismi di difesa dell'Io
05	Dispercepire il mondo	Semiologia, funzioni cognitive, psicofarmaci
06	Sindromi affettive e ansiose	Depressioni, bipolari, disturbi d'ansia
07	Le nevrosi	DOC e isteria: conflitto egodistonico
08	I disturbi di personalità	Struttura del carattere, cluster A/B/C, BPD
09	Le psicosi	Schizofrenia, psicosi organiche e funzionali

#	Lezione	Tema centrale
10	Il corpo sessuato	Sessualità, identità di genere, parafilie, disforia di genere
11	Il corpo deformato	DCA: anoressia, bulimia, BED, ortoressia, vigoressia
12	Il corpo alessitimico	Alessitimia, regolazione affettiva, dipendenze
13	Il corpo violato	Rabbia, aggressività, violenza domestica, disimpegno morale

Cornice concettuale: salute, malattia, normalità

Il modulo si apre definendo i termini che stanno alla base di tutto il resto.

- **Salute** → 7 condizioni di **Boorse** (1977): valore, trattamento medico, norma statistica, sofferenza, disabilità, adattamento, omeostasi · nessuna sufficiente da sola · (Lez. 01)
- **Disease / Illness / Sickness** → dimensione biomedica, soggettiva, sociale · possono non coincidere · lo stigma peggiora il decorso · (Lez. 01)
- **Benessere** → 6 dimensioni di **Ryff**: autonomia, controllo ambientale, relazioni positive, autoaccettazione, crescita, scopo · salute ≠ benessere · (Lez. 01)
- **Normalità** → statistica · di valore · personale · ogni tipo ha il suo rischio di stigma o sofferenza · (Lez. 01)
- **To cure vs. to care** → guarire non sempre possibile, curare sì · *"Non tutto si può guarire, ma tutto può essere curato"* · (Lez. 01)
- **Posizione del soggetto** → agente/passivo × identificato/non identificato con la malattia · (Lez. 01)
- **Patologia vs. normalità** → 3 criteri: durata, intensità, compromissione · (Lez. 07)

I due paradigmi della follia

Tema centrale in Lez. 02, riecheggia in tutte le altre.

- **Gehirnpsychiatrie** → follia = malattia organica del cervello · (Lez. 02)
 - **Geistespsychiatrie** → follia = passioni, traumi, vita · (Lez. 02)
 - **Comprensibilità (Jaspers)** → follia passionale comprensibile · follia organica incomprensibile · (Lez. 02)
 - **Somatiker vs. Psychiker** → declinazione ottocentesca del dualismo (Griesinger) · (Lez. 02)
 - **Alienazione** → essere "altrove", fuori dal proprio mondo · (Lez. 02)
 - **Avere vs. essere la malattia** → non-identificazione vs. identificazione identitaria → paradigmi di cura diversi · (Lez. 01, 02)
 - **Nevrosi** nasce qui (Cullen, 1777) e riemerge come tema centrale in Lez. 07
 - **Psicosi organiche vs. funzionali** → distinzione già implicita nei due paradigmi; sistematizzata in Lez. 09 (Minkowski): organiche = struttura io–qui–adesso crollata; funzionali = struttura intatta ma dissociata · (Lez. 09)
-

Evoluzione storica della psichiatria

- **Grecia** → **Ippocrate** → emancipazione dalla religione · teoria degli umori · fluidisti · (Lez. 02)
- **Medioevo** → religione domina; nessuna novità · (Lez. 02)
- **1500–1700** → rinascita scientifica · "Homme machine" · nevrosi (Cullen) · nevrastenia (Beard) · (Lez. 02)
- **Pinel** → Bicêtre 1793 · **guaribilità, patoplastica, parzialità della follia, trattamento morale** · (Lez. 02, ripreso in Lez. 07)
- **Esquirol** → passionale curabile vs. organica incurabile · idiozia vs. demenza · (Lez. 02)
- **Positivismo XIX sec.** → Griesinger · Morel (degenerazione, delirio paranoico) · Lombroso (atavismo) · Krafft-Ebing · (Lez. 02)
- **Kraepelin** → nosologia · endogene/esogene · psicosi maniaco-depressiva vs. demenza precoce · (Lez. 02, base per Lez. 06, 09)

- **Bleuler 1911** → schizofrenia · sintomi primari/secondari · recupera la patoplastica · (Lez. 02, 09)
 - **Charcot** → **Freud** → passaggio dall'ipnosi alla dinamica inconscia · (Lez. 07)
 - **DSM-III in poi** → abbandono del termine "nevrosi", frammentazione in diagnosi specifiche · (Lez. 07)
-

Emozioni: filiera, paura, ansia, umore

Lez. 04 e Lez. 06 condividono tutta la filiera emotiva.

- **Emozione** → reattiva, acuta, con oggetto (Galimberti) · **Umore** → disposizione di fondo (Delay) · (Lez. 06)
 - **Emozioni di base** → Ekman & Friesen (6) · Plutchik (8 + fiore: intensità, attenuazione, combinazioni) · (Lez. 06)
 - **Filiera della paura** → minaccia → valutazione protocognitiva → paura → fuga / attacco / mimetismo · (Lez. 04)
 - **Paura vs. ansia** → oggetto presente (amigdala) vs. futuro ipotetico (BNST) · ansia = paura + anticipazione (Plutchik) · (Lez. 04, 06)
 - **Freezing** → intensità eccessiva supera soglia di arousal · (Lez. 04)
 - **Ansia normale vs. patologica** (Biondi) · **ansia di stato vs. di tratto** (Sims & Snaith) · (Lez. 04, 06)
 - **Rimuginio ansioso vs. ruminazione depressiva** → futuro vs. passato · alimenta ansia vs. prolunga depressione · (Lez. 06)
 - **Sorpresa · Angoscia** → angoscia reale = paura; angoscia nevrotica = ansia (Freud) · (Lez. 04)
 - **Fonti di angoscia (Freud 1930)** → corpo · natura · relazioni (porcospini di Schopenhauer) · (Lez. 04)
-

Meccanismi di difesa e struttura della personalità

Ponte tra Lez. 04 (classificazione), Lez. 07 (nevrosi), Lez. 08 (disturbi di personalità) e Lez. 09 (psicosi).

- **MDD** → risposta automatica, inconscia, dell'Io contro l'angoscia ($\neq$ coping) · (Lez. 04)
 - **3 criteri Anna Freud** → age adequateness · intensity · balance · (Lez. 04)
 - **Primitivi** → ritiro · diniego · proiezione · introiezione · identificazione proiettiva · scissione · idealizzazione · svalutazione · controllo onnipotente · (Lez. 04)
 - Dominanti nel **cluster A e B** dei disturbi di personalità e nella struttura borderline (Lez. 08)
 - **Maturi / secondari** → rimozione · dissociazione · formazione reattiva · spostamento · capovolgimento · isolamento affetti · intellettualizzazione · razionalizzazione · moralizzazione · compartimentalizzazione · umorismo · (Lez. 04)
 - **Scala di Perrotta (adatt. Pezzoli)** → 7 livelli da rottura con la realtà a difese mature · (Lez. 04)
 - **Angosce per area clinica** → nevrosi = castrazione · psicosi = frammentazione · borderline = abbandono · (Lez. 04, ripresa in Lez. 07, 08, 09)
 - **Struttura nevrotica (Bergeret)** → Super-Io dominante · conflitto edipico · difesa = rimozione · relazione genitale · diagnosi solo da adulti · (Lez. 07)
 - **Linea di divisione (Abraham)** → sotto-stadio anale evacuazione (psicotico) / ritenzione (nevrotico) · (Lez. 07)
 - **Difese nel DOC** → rimozione · formazione reattiva · spostamento · isolamento · annullamento retroattivo · tutte già viste in Lez. 04 · (Lez. 07)
 - **Organizzazione di personalità (Kernberg)** → struttura nevrotica / borderline / psicotica · identità, difese, esame di realtà come tre assi diagnostici · (Lez. 08)
-

Empatia e relazione di cura

- **Einfühlung** → "sentire dentro" · Lipps (1905) · (Lez. 03)
 - **Critica del "mettersi nei panni"** → stare accanto, non al posto dell'altro (Ricoeur, Pezzoli) · (Lez. 03)
 - **Simulazione incarnata** → Gallese · neuroni specchio · automatica, pre-riflessiva · (Lez. 03)
 - **Modello Feshbach** → 3 componenti: assunzione di prospettiva · decodifica emotiva · risonanza · TOM (Wellman: DD/DB/KA/FB/HE) · preconditione sé/altro · (Lez. 03)
 - **Modello Hoffman** → empatie al plurale · evolutive · motivazionali · 5 stadi dal distress globale all'empatia oltre la situazione · (Lez. 03)
 - **Contagio emotivo** → imitazione motoria (Ekman 1992) · reazione circolare primaria · (Lez. 03)
 - **Empatia / simpatia / compassione** → feeling with vs. feeling for (Singer & Klimecki) · (Lez. 03)
 - **6 bias empatici (Pezzoli)** → similarità · giudizio morale · inganno/invidia · insensibilità numerica · non rende più buoni · faticosa · → burnout · (Lez. 03)
 - **Empatia egocentrica** → aiutare con ciò che consola sé: la "lezione 3" del mito di Medusa riprende il tema · (Lez. 03, 04)
 - **To care** come cura sempre possibile si poggia sull'empatia matura · (Lez. 01, 03)
-

Semiologia: come si guarda il paziente

Lez. 05 è la cassetta degli attrezzi clinici.

- **Segni vs. sintomi** → oggettivi / soggettivi · (Lez. 05)
- **Semiologia del comportamento** → apparenza (ipertimia, amimia, mimica discordante) · discorso · condotte istintuali · passaggi all'atto · funzioni psicomotorie (catatonia, tic, stereotipie) · (Lez. 05)
- **Semiologia dello stato mentale** →
 - **Coscienza** → quantitative (lucidità → coma) / qualitative (delirium, oniroide, crepuscolare, mania à potu) · (Lez. 05)

- **Orientamento** → tempo, spazio, persona · persona alterata = massima gravità · (Lez. 05)
 - **Memoria** → sensoriale, breve, lavoro, lungo termine · disturbi quantitativi (amnesie, ipo/ipermnesia) e qualitativi (confabulazioni, déjà vu) · (Lez. 05)
 - **Attenzione** → selettiva, divisa, sostenuta · (Lez. 05)
 - **Percezione** → sensazione vs. percezione · illusione vs. allucinazione · agnosie, prosopagnosia, anosognosia · (Lez. 05)
 - **Funzioni cognitive** → memoria, attenzione, esecutive, linguaggio, prassie, gnose, emozioni · (Lez. 05)
 - **Neurotrasmettitori** → dopamina, serotonina, noradrenalina, GABA, glutammato, acetilcolina · (Lez. 05)
-

Quadri clinici maggiori

Sindromi affettive (Lez. 06)

- **Nucleo depressivo comune (Klein)** → umore depresso · rallentamento psicomotorio e psichico · anedonia · apatia · alfa privativo
- **Classificazione Lalli (2002)** → primarie (carattere depressivo) vs. secondarie (organiche)
- **Tre gruppi clinici** → psicogene (vittima, reattivo) · endogene (colpevole, non reattivo) · somatiche
- **DSM-5-TR** → disturbo depressivo maggiore (≥ 2 sett.) · persistente (≥ 2 anni) · depressione mascherata ($\neq$ ipocondria)
- **Disturbi bipolari** → pendolo timico · bipolare I / II / ciclotimico · episodio maniacale (insonnia senza stanchezza, fuga di idee, perdita contatto con realtà) · ⚠ no antidepressivi in solitaria
- **Terapia** → stabilizzatori · litio (monitoraggio ematico) · psicoeducazione

Sindromi ansiose (Lez. 06)

- **Sintomi** → cognitivi, affettivi, fisiologici, comportamentali

- **Disturbi d'ansia DSM-5-TR** → DAG (rimuginio) · ansia sociale (vergogna) · panico · agorafobia · fobia specifica · ansia da separazione · mutismo selettivo
- **Attacco di panico** → picco in pochi minuti · ≥ 4 su 13 sintomi · accoglienza senza giudizio
- **DOC e PTSD** → non più nei disturbi d'ansia nel DSM-5-TR

Nevrosi (Lez. 07)

- **Definizione** → disturbo psichico senza causa organica · conflitto desiderio/regola non risolto → sintomo · non è malattia
- **Sintomo egodistonico** (nevrosi) vs. **egosintonico** (disturbi personalità) → consapevolezza, sofferenza, richiesta di aiuto
- **Fenomenologia** → bassa autostima, colpa, vergogna · ansia dominante · sintomi somatici · esame di realtà mantenuto ($\neq$ psicosi)
- **DOC** → luogo del sintomo = pensiero · ossessioni (non desiderate, incongruenti, si resiste) · compulsioni (solievo $\neq$ piacere) · evitamento
- **Isteria** → luogo del sintomo = corpo · hystéra = utero · Ippocrate → Charcot (4 fasi) → Freud · **conversione** del conflitto sul piano somatico · isterica di conversione vs. d'angoscia (fobia, spostamento)
- **Nel DSM-5-TR** → le nevrosi classiche si sono frammentate in disturbi d'ansia, DOC, traumatici, somatici, dissociativi

Disturbi di personalità (Lez. 08)

- **Personalità** → temperamento (biologico, congenito) + carattere (acquisito) = modalità stabili di pensare · sentire · comportarsi · relazionarsi
- **Tratto vs. stato** → tratto = stabile (base dei disturbi di personalità) · stato = temporaneo (base delle sindromi cliniche come la depressione maggiore)
- **Da stile a disturbo** → tratti rigidi e pervasivi → sofferenza e/o compromissione · modello bio-psico-sociale (Paris): diatesi + stress = disturbo
- **Egosintonia** → tratti non percepiti come problematici → scarsa motivazione al trattamento
- **Spettro internalizzante vs. esternalizzante** → soffrono dentro (evitante, dipendente, schizoide) vs. fanno soffrire gli altri (paranoide, narcisistico, antisociale) · BPD oscilla tra i due

- **Cluster A** — strani ed eccentrici:
 - **Paranoide** → diffidenza pervasiva · difese: proiezione, identificazione proiettiva
 - **Schizoide** → distacco relazionale · difesa: ritiro
 - **Schizotipico** → distorsioni cognitive/percettive · più vicino alla psicosi
- **Cluster B** — drammatici, emotivi, imprevedibili:
 - **Antisociale** → violazione diritti altrui · criterio: disturbo della condotta prima dei 15 anni
 - **Borderline (BPD)** → instabilità relazioni/identità/umore · scissione · angoscia di abbandono · suicidalità in 80% dei ricoverati · ~20% dei pazienti psichiatrici (Gunderson) · difese: scissione, identificazione proiettiva, dissociazione, acting out
 - **Narcisistico** → grandiosità, mancanza empatia emotiva · difese: idealizzazione, svalutazione
- **Cluster C** — ansiosi e inibiti:
 - **Evitante** → inibizione sociale · vuole le relazioni ≠ schizoide
 - **Dipendente** → bisogno pervasivo di accudimento
 - **DOCP** → ordine e controllo · egosintonico ≠ DOC
- **Organizzazione di personalità (Kernberg)** → nevrotica / borderline / psicotica: differiscono per identità, difese, esame di realtà · (Lez. 08)
- **Trattamenti validati per BPD** → DBT (Linehan) · MBT · TFP (Kernberg)
- **Problema diagnostico** → DSM categoriale ↔ psicopatologia dimensionale · PDM-2 (Lingiardi & McWilliams) come alternativa

Psicosi (Lez. 09)

- **Definizione** → rapporto radicalmente alterato con la realtà · due destrutturazioni (Jervis): realtà esterna + identità interna
- **Psicosi organiche** → causa biologica nota · io–qui–adesso crollato:
 - **Demenze** → Alzheimer, senile, acquisite (alcol, sifilide)
 - **Epilessia** → grande male (tonica → clonica → risolutiva) · piccolo male (assenza breve, senza convulsioni) · crisi parziali
 - **Psicosi da sostanze** → sistema mesolimbico/dopamina · delirium tremens (astinenza alcolica) · Korsakov (amnesia anterograda cronica) · cannabis indoor (THC alto → rischio psicotico)

- **Psicosi funzionali** → causa multifattoriale · struttura io–qui–adesso intatta ma dissociata (sa ma non si sente)
 - **Sintomatologia comune** → sintomi positivi (delirio + allucinazioni) · negativi (apatia, abulia, ritiro) · disorganizzazione cognitiva
 - **Schizofrenia** → Bleuler 1911 · *schizein* + *phren* · orchestra senza direttore · sindrome fondamentale:
 - **Dissociazione** intellettuale (disorganizzazione, impoverimento, concretismo, tangenzialità, deragliamento) · affettiva (appiattimento, discordanza, ambivalenza) · psicomotoria (riduzione, agitazione, crisi pantoclastica, manierismi)
 - **Autismo schizofrenico** → perdita del contatto vitale con la realtà
 - **Delirio** → convinzione falsa, incrollabile, non riducibile alla logica (Sims) · contenuti: persecuzione, grandiosità, influenzamento...
 - **Depersonalizzazione / Derealizzazione** → sé come automa · mondo come estraneo · tempo cristallizzato
 - **Allucinazioni** → prevalentemente uditive · indistinguibili dal reale · ⚠ voci perentorie con ordini pericolosi
 - **Tipo 1 vs. Tipo 2 (Crow, 1980)** → positivi/reversibili vs. negativi/cronici
 - **Decorso** → premorbo → prodromico → stato (~20 anni) → esiti · ⚠ picco suicidalità nel miglioramento, non nello scompenso
 - **Fattori prognostici** → favorevoli: diagnosi precoce, buon funzionamento premorbo, sesso femminile, rete sociale · sfavorevoli: esordio precoce, familiarità, sintomi negativi dominanti
-

Psicofarmacologia (Lez. 05)

- **Emivita · farmacodinamica · farmacocinetica** → base
 - **Antipsicotici** → tipici (1952) vs. atipici (anni '90) · sintomi positivi
 - **Antidepressivi** → bifasici · rischio suicidale prime settimane
 - **Ansiolitici** → benzodiazepine: effetto immediato, dipendenza
 - **Stabilizzatori** → litio, monitoraggio ematico
 - ⚠ Non dedurre la diagnosi dalla terapia · ⚠ terapia sempre integrata
-

Il corpo nella sofferenza mentale

Il corpo sessuato (Lez. 10)

- **Definizione OMS** → sessualità = aspetto centrale dell'essere umano per l'intero arco della vita · include sesso, identità di genere, orientamento, erotismo, piacere, intimità, riproduzione
- **Galimberti** → sessualità come sviluppo psicologico e relazionale · parte dalla relazione madre-bambino · va oltre la riproduzione: simbolizzazione, sublimazione
- **Körper vs. Leib (Husserl)** → corpo-oggetto anatomico vs. corpo vissuto relazionale · nelle parafilie il corpo altrui è vissuto come *Körper*
- **Finalità della sessualità (Grazzottin)** → amorosa · ricreativa · procreativa · strumentale (disfunzionale se causa danno)
- **Identità sessuale: 4 dimensioni** →
 - **Sesso biologico** → caratteristiche fisiche alla nascita (AFAB / AMAB / intersex ~1,7%)
 - **Identità di genere** → sensazione intima di sé (cisgender · transgender · gender fluid · agender)
 - **Ruolo di genere** → aspettative socioculturali
 - **Orientamento sessuale** → direzione dell'attrazione
- **Bisogno vs. desiderio** → bisogno = immediato, non differibile · desiderio = differibile, passaggio evolutivo sano · bisogno non superato → compulsività → base delle parafilie
- **6 snodi di Lalli** → umanizzazione · dipendenza→autonomia · bisogno→desiderio · riconoscimento reciproco · fantasia · rapporto con l'altro · ogni snodo ha versione sana e versione patologica
- **DSM-5-TR: 3 categorie** → disfunzioni sessuali · disforia di genere · disturbi parafilici
- **Disforia di genere** → focus sulla sofferenza, non sulla condizione · transgender ≠ disforia (non tutti i trans soffrono) · diagnosi necessaria per terapia ormonale/chirurgica · criteri: A (incongruenza ≥ 6 mesi) + B (sofferenza clinicamente significativa)

- **Parafilia vs. disturbo parafilico** → parafilia = interesse intenso/persistente non convenzionale · disturbo = parafilia + disagio personale o danno a sé/altri · parafilia = condizione necessaria ma non sufficiente
- **8 disturbi parafilici (DSM-5)** → voyeuristico · esibizionistico · pedofilico · feticcistico · da travestitismo · da masochismo sessuale (variante: asfissiofilia) · da sadismo sessuale · frotteuristico

Il corpo deformato: disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (Lez. 11)

- **Cibo come primo mediatore relazionale** → il neonato incontra il mondo attraverso l'alimentazione · il nutrimento prefigura le relazioni future · il gusto è elaborato da ippocampo e amigdala, mai neutro
- **Identità culturale del cibo** → confine tra sé e l'altro, tra gruppi sociali · tendenza attuale: pasto da momento di unione a divisione ("tribù alimentari" — Niola)
- **DNA (DSM-5-TR)** → pica · ruminazione · evitante/restrittivo · anoressia nervosa (restrizione + paura peso + distorsione immagine) · bulimia nervosa (abbuffate + compensatori) · BED (abbuffate senza compensazione · riconosciuto come entità autonoma nel 2013)
- **DCA come disturbi etnici (Devereux)** → ⚠ cultura = **fattore patoplastico** (Jaspers): plasma la *forma* della sofferenza, non ne è la causa · non: "la moda causa l'anoressia" · sì: "chi ha una vulnerabilità si ammala nella forma che la cultura indica"
- **Scissione mente-corpo (Selvini-Palazzoli)** → il corpo pubere diventa persecutorio · difficoltà di separazione-individuazione (Mahler) · DCA come patologie narcisistiche
- **Falso sé compiacente (Bruch)** → "bambine perfette" con bisogni non riconosciuti · il sintomo alimentare = unico spazio di autonomia e controllo
- **Dialettica dipendenza/autonomia** → abbuffata = riempire il vuoto · vomito = spingere via · restrizione = illusione di bastare a sé stessi
- **Ortoressia** (ossessione qualità) · **Vigoressia** (Muscle Dysmorphia — Pope, 1993) → "anoressia inversa"
- **Dispercezione corporea** → errore nella stima di sé · tecnica: disegnare l'immagine percepita → sovrapporre il contorno reale

- **Eziologia multifattoriale** → predisponenti (genetici, psicologici, familiari, socioculturali) · precipitanti (lutti, traumi, fallimenti) · cronicizzanti (spinta biologica, distorsione immagine)
- **Identità liquida** → il sintomo offre un'identità chiara e stabile, sebbene disfunzionale

Il corpo alessitimico (Lez. 12)

- **Alessitimia** (Sifneos, 1973) → mancanza di parole per le emozioni (*a + lexis + thymos*)
- **4 caratteristiche (Taylor)** → difficoltà a discriminare le emozioni · vocabolario emotivo limitato · fantasia deficitaria · stile cognitivo verso l'esterno
- ⚠ Le persone alessitimiche *provano* le emozioni — non riescono a nominarle
- **Tratto** (sviluppo infantile bloccato, stabile) vs. **Stato** (post-trauma, potenzialmente reversibile)
- **Costrutto transnosografico** → presente in psicosomatica, umore, ansia, dipendenze, DCA, disturbi di personalità · **non nelle psicosi**
- **Trauma e alessitimia (Krystal)** → pericolo inevitabile → congelamento affettivo → sollievo paradossale · trauma infantile blocca desomatizzazione e verbalizzazione
- **Intelligenza emotiva (Salovey & Mayer)** → 4 dimensioni: percezione/espressione · facilitazione del pensiero · comprensione/analisi · regolazione consapevole
- **Alessitimia e dipendenze** → la sostanza come stampella per regolare (o bloccare) le emozioni · attaccamento insicuro nell'infanzia come fattore frequente
- **Strumenti** → TAS-20 (autovalutazione, 20 item, dalla ricerca) · SAR · TSIA (intervista) · ⚠ non fanno diagnosi, sono campanelli d'allarme

Il corpo violato (Lez. 13)

- **Triade fondamentale** → **rabbia** (emozione, legittima) ≠ **aggressività** (forza orientata, benigna o maligna) ≠ **violenza** (declinazione maligna intenzionale) · non sono sinonimi

- **Aggressività maligna a caldo** (reattiva, perde controllo, senso di colpa dopo · BPD) vs. **a freddo** (predatoria, pianificata, nessun senso di colpa · antisociale)
 - **Introdiretta vs. eterodiretta** → introdiretta evolutivamente più grave: viola il principio di autoconservazione
 - **Mappa 2×2** → attiva/passiva × diretta/indiretta
 - **Metafora del fiume** → canalizzazione educativa trasforma la forza in risorsa · si costruisce nei periodi di calma
 - **Violenza domestica (OMS)** → ogni forma di violenza fisica, psicologica o sessuale in ambito familiare o di coppia · la psicologica è la prima ad apparire e la più invisibile
 - **Ciclo della violenza (Walker, 1979)** → accumulo → esplosione → ridimensionamento/colpa alla vittima → falsa riappacificazione → ricomincia
 - **Strategie di risposta (Mannino, Cataudella, Zappalà)** → ripiegamento · aggirare · resistenza · separazione
 - **Ruota del potere e del controllo (Progetto Duluth)** → motore: controllo · raggi: isolamento, violenza economica, intimidazioni, denigrazione, stalking
 - **Meccanismi di disimpegno morale (Bandura, 2017)** → sospendono la moralità senza modificarla: giustificazione morale · etichettamento eufemistico · spostamento/diffusione responsabilità · deumanizzazione · attribuzione di colpa alla vittima · ⚠️ abitano tutti noi — vigilare nelle equipe
 - **Banalità del male (Arendt)** → il male si insinua nella quotidianità burocratica · solo il bene è radicale
-

Dimensione identitaria e incontro clinico

Filo che attraversa tutto il modulo.

- **4 dimensioni trasversali** → spazio · tempo · identità · incontro · (Lez. 01)
- **Crisi identitaria della follia** → chi sono? dove sono? in che tempo vivo? · vocabolario spaziale popolare · (Lez. 02)
- **Cargnello** → ambiguità irriducibile della psichiatria: "essere con qualcuno" vs. "avere qualcosa di fronte" · clinica = incontro · (Lez. 02)

- **Operatore sociale** → trait d'union tra discipline specialistiche · (Lez. 01)
- **Mito di Medusa (Ovidio)** → i "mostri" sono spesso vittime trasformate da ciò che hanno subito · (Lez. 04)
- **Diffusione dell'identità (Kernberg)** → il sé e gli altri poco integrati come tratto centrale dell'organizzazione borderline e psicotica · (Lez. 08)
- **Depersonalizzazione/derealizzazione** → il sé come automa, il tempo cristallizzato → la crisi identitaria al suo grado più estremo nella psicosi · (Lez. 09)

Autori e riferimenti principali

Chi	Contributo	Lezione
Boorse	7 condizioni della salute (1977)	01
Ryff	6 dimensioni del benessere	01
Callieri	Definizione di clinica (1999)	01
Guidorizzi	Follia nella tragedia greca (2010)	01
Ippocrate	Teoria degli umori; emancipazione dalla religione	02
Empedocle	Equilibrio tra poli contrari	02
Pinel	Trattamento morale; Bicêtre 1793; guaribilità, patoplastica, parzialità	02, 07
Esquirol	Follia passionale vs. organica; idiozia vs. demenza	02
Cullen	Conia "nevrosi" (1777)	02, 07
Beard	Nevrastenia	02
Griesinger	Follia = malattia del cervello; Somatiker/Psychiker	02
Morel		02, 09

Chi	Contributo	Lezione
	Degenerazione; demenza precoce; alienazione mentale	
Lombroso	Antropologia criminale; atavismo	02
Kraepelin	Nosologia endogene/esogene; psicosi MD; demenza precoce	02, 09
Bleuler	Schizofrenia (1911); sintomi primari/secondari; gruppo delle schizofrenie	02, 09
Jaspers	Comprensibilità vs. incomprendibilità; fattore patoplastico	02, 11
Cargnello	Ambiguità della psichiatria; clinica come incontro	02
Charcot	Isteria; ipnosi; Salpêtrière	07
Freud	Difese (1894); disagio della civiltà (1930); dinamica inconscia; conversione	04, 07
Anna Freud	L'Io e i meccanismi di difesa (1936); 3 criteri	04
Klein	Posizione schizoide/depressiva; nucleo semiologico depressioni	04, 06
Abraham	Linea di divisione nevrotico/psicotico	07
Bergeret	Struttura nevrotica/psicotica; scompenso	07
McWilliams	Tipologie di personalità; "nevrotico" = alto livello di funzionamento	07, 08
Lipps	Einfühlung (1905)	03
Feshbach		03

Chi	Contributo	Lezione
	Modello multidimensionale dell'empatia	
Hoffman	Empatie al plurale; modello evolutivo	03
Gallese	Simulazione incarnata; neuroni specchio	03
Tisseron	Empatia intersoggettiva; verso sé stessi	03
Bloom	Contro l'empatia; bias	03
Singer & Klimecki	Compassione = feeling for	03
Pezzoli	6 bias empatici; schema contesto × minaccia	03, 04
Ekman & Friesen	6 emozioni di base (1971)	04, 06
Plutchik	Modello multidimensionale; fiore delle emozioni	04, 06
Galimberti / Delay	Definizioni di emozione / umore	06
Lalli	Depressioni primarie vs. secondarie (2002); 6 snodi psicosessuali	06, 10
Sims & Snaith	Ansia di stato vs. di tratto	06
Biondi	Ansia normale vs. patologica	04
Grillon	Amigdala (paura) vs. BNST (ansia)	04
Perrotta	Scala potenziale disadattivo dei MDD (2020)	04
Schopenhauer	Porcospini → distanza relazionale	04
Ovidio	Metamorfosi; mito di Medusa	04
Thomas, Chess & Birch	9 variabili temperamentali; bambini facili/difficili/lenta attivazione	08

Chi	Contributo	Lezione
Eysenck / Costa & McCrae	Modelli di tratti (Big Five)	08
Reich	Corazza caratteriale	08
Paris	Modello bio-psico-sociale dei disturbi di personalità (1997)	08
Gunderson & Links	BPD = ~20% dei pazienti psichiatrici	08
Linehan	DBT; BPD come "ustioni di terzo grado"	08
Kernberg	Organizzazione borderline/nevrotica/psicotica; TFP	08
Lingiardi & McWilliams	PDM-2; approccio dimensionale e psicodinamico	08
Minkowski	Triade io–qui–adesso; psicosi organiche vs. funzionali	09
Jervis	Due destrutturazioni centrali nella psicosi	09
Crow	Tipo 1 (positivi) / Tipo 2 (negativi) della schizofrenia (1980)	09
Stanghellini & Ballerini	Vulnerabilità premorbosa; identikit del futuro paziente	09
APA	DSM-5-TR (2023)	06, 07, 08, 10
Pewzner / Sims / Baddeley / Faravelli / Stahl	Semiologia, memoria, psicofarmaci	05
Husserl	Körper vs. Leib — corpo-oggetto vs. corpo vissuto	10

Chi	Contributo	Lezione
Krafft-Ebing	<i>Psychopathia Sexualis</i> — primo catalogo scientifico della sessualità (1886)	02, 10
Kinsey	Rapporto Kinsey — studio comportamentale su 18.000 persone	10
Masters & Johnson	<i>Human Sexual Response</i> — ciclo della risposta sessuale (1966)	10
Grazzottin	Tassonomia delle finalità della sessualità	10
Selvini-Palazzoli	Scissione mente-corpo nell'anoressia (1963)	11
Bruch	"La gabbia d'oro" — anoressia come malattia borghese; falso sé (1978)	11
Devereux	Disturbi etnici / Culture-Bound Syndromes (1978)	11
Cosenza	Quattro epoche storiche del sintomo anoressico (2008)	11
Pope	Prima descrizione della vigoressia "anoressia inversa" (1993)	11
Niola	"Homo dieteticus" — tribù alimentari (2015)	11
Mahler	Separazione-individuazione — fattore predisponente nei DCA	11
Sontag	"Malattia come metafora" — malattie simbolo di un'epoca (1978)	11
Sifneos	Conia il termine "alessitimia" (1973)	12
Taylor		12

Chi	Contributo	Lezione
	Definizione aggiornata dell'alessitimia (4 caratteristiche)	
Krystal	Trauma e alessitimia; congelamento affettivo; risposta al pericolo	12
Salovey & Mayer	4 dimensioni intelligenza emotiva	12
Wurmser / Khantzian	Affetti e dipendenze	12
Marty & M'Uzan	Pensiero operatorio — concreto, senza fantasia (1963)	12
Fromm	Aggressività benigna vs. maligna (1973)	13
Wrangham	Aggressività reattiva vs. predatoria (2019)	13
Walker	Ciclo della violenza domestica (1979)	13
OMS	Definizione violenza e violenza domestica (1996, 2002)	13
Progetto Duluth	Ruota potere e controllo	13
Bandura	Meccanismi di disimpegno morale (2017)	13
Milgram	Obbedienza all'autorità (1963)	13
Arendt	Banalità del male	13
Mannino, Cataudella, Zappalà	Strategie di risposta alla violenza (2003)	13

Parole chiave della materia

salute · benessere · normalità · disease · illness · sickness · to cure · to care · agentività · clinica · Gehirnpsychiatrie · Geistespsychiatrie · Somatiker · Psychiker · teoria degli umori · trattamento morale · patoplastica · parzialità della follia · degenerazione · nosologia · schizofrenia · psicosi maniaco-depressiva · alienazione · comprensibilità · pellagra · Einfühlung · empatia cognitiva · empatia affettiva · simulazione incarnata · neuroni specchio · Theory of Mind · decentramento · compassione · bias empatico · sovrattivazione empatica · paura · ansia · angoscia · freezing · arousal · amigdala · BNST · filiera emotiva · meccanismi di difesa · ritiro primitivo · diniego · proiezione · scissione · idealizzazione · rimozione · dissociazione · formazione reattiva · spostamento · isolamento affetti · intellettualizzazione · umorismo · angoscia di castrazione · angoscia di frammentazione · angoscia di abbandono · semiologia · segni · sintomi · catatonia · coscienza · orientamento · amnesia · confabulazione · illusione · allucinazione · agnosia · anosognosia · farmacodinamica · farmacocinetica · antipsicotici · antidepressivi · ansiolitici · stabilizzatori · litio · emozione · umore · eutimia · anedonia · apatia · alfa privativo · pendolo timico · depressione mascherata · bipolare I · bipolare II · ciclotimico · rimuginio · ruminazione · DAG · attacco di panico · nevrosi · egodistonico · egosintonico · struttura nevrotica · scompenso · esame di realtà · ossessioni · compulsioni · sollievo vs. piacere · conversione · isteria · DOC · conflitto edipico · temperamento · carattere · personalità · tratto · stato · goodness of fit · diatesi · corazza caratteriale · egosintonia · diffusione dell'identità · organizzazione borderline · cluster A/B/C · BPD · DBT · Big Five · PDM-2 · psicosi · organica · funzionale · io-qui-adesso · dissociazione schizofrenica · delirio · autismo schizofrenico · depersonalizzazione · derealizzazione · sintomi positivi ·

sintomi negativi · disorganizzazione · tipo 1 · tipo 2 · delirium tremens · Korsakov · epilessia · crisi pantoclastica · Körper · Leib · sessualità · identità di genere · orientamento sessuale · sesso biologico · cisgender · transgender · gender fluid · agender · intersex · AFAB · AMAB · disforia di genere · parafilia · disturbo parafilico · bisogno vs. desiderio · snodi di Lalli · asfissiofilia · frotteurismo · DNA · anoressia nervosa · bulimia nervosa · BED · ortoressia · vigoressia · Muscle Dysmorphia · Culture-Bound Syndrome · disturbo etnico · fattore patoplastico · separazione-individuazione · falso sé · dispercezione corporea · scissione mente-corpo · fattori predisponenti · fattori precipitanti · fattori cronicizzanti · alessitimia · desomatizzazione · verbalizzazione · pensiero operatorio · transnosografico · TAS-20 · intelligenza emotiva · regolazione affettiva · congelamento affettivo · attaccamento insicuro · rabbia · aggressività · violenza · ostacolo · canalizzazione · aggressività maligna a caldo · aggressività maligna a freddo · ciclo della violenza · falsa riappacificazione · ruota del potere · disimpegno morale · deumanizzazione · banalità del male · violenza domestica · violenza psicologica

Filo conduttore

Si parte chiedendo cosa sia la salute e si scopre subito che non c'è una risposta unica: salute, malattia, normalità e benessere sono costrutti che non coincidono mai del tutto (Lez. 01). La storia della follia mostra che la psichiatria ha sempre oscillato tra due paradigmi — organico e passionale — e che ogni epoca ha riscritto il confine tra ciò che è curabile e ciò che non lo è (Lez. 02). Per stare davvero accanto a chi soffre servono strumenti: l'empatia nelle sue diverse forme e con i suoi bias (Lez. 03); la capacità di leggere le emozioni e le difese che il soggetto mette in campo contro l'angoscia (Lez. 04); una semiologia precisa per osservare comportamento, coscienza, memoria, percezione (Lez. 05). Con questi strumenti si arriva ai grandi quadri clinici: dalle sindromi affettive e ansiose (Lez. 06) alle nevrosi — dove il conflitto è ancora egodistonico e l'esame di realtà mantenuto (Lez. 07) — fino ai

disturbi di personalità, dove i tratti rigidi sono egosintonici e la sofferenza spesso ricade sugli altri (Lez. 08), e alle psicosi, dove il rapporto con la realtà si rompe o si dissocia in modo radicale (Lez. 09). La traiettoria è un continuum: non categorie stagno, ma gradi crescenti di compromissione dell'identità, della relazione con l'altro e del contatto con il reale. Il modulo si chiude con una quadrupla finestra sul corpo: sessuato (Lez. 10), dove il passaggio dal bisogno al desiderio è un marker evolutivo fondamentale; deformato (Lez. 11), dove i disturbi della nutrizione mostrano come la cultura faccia da fattore patoplastico dando forma a conflitti di separazione e identità; alessitimico (Lez. 12), dove la sofferenza psichica non trova parole e si deposita sul piano somatico o si affievolisce nelle dipendenze; violato (Lez. 13), dove la rabbia — emozione legittima — diventa violenza quando non trova canali di canalizzazione, e i meccanismi di disimpegno morale ci ricordano che il rischio di fare del male abita anche chi lavora in aiuto. Il filo rosso, ribadito da Cargnello fin dall'inizio, resta uno solo: la clinica è l'incontro con qualcuno, mai la gestione di qualcosa.

Domande di orientamento allo studio

1. Qual è il filo conduttore dell'intera materia di Salute Mentale?

Il modulo costruisce progressivamente gli strumenti per incontrare chi soffre. Si parte dalle definizioni fondamentali di salute, malattia e normalità (Lez. 01) e dalla storia della psichiatria come oscillazione tra paradigma organico e passionale (Lez. 02). Si acquisiscono poi strumenti relazionali (empatia, Lez. 03), emotivi e difensivi (Lez. 04) e osservativi clinici (semiologia, Lez. 05). Infine si applicano questi strumenti ai grandi quadri clinici — sindromi affettive e ansiose, nevrosi, disturbi di personalità, psicosi — e al corpo nelle sue diverse forme di sofferenza (Lez. 10–13), in un continuum che va dalla nevrosi (esame di realtà mantenuto) alla psicosi (esame di realtà compromesso). Il filo rosso è sempre uno: la clinica è incontro, non classificazione.

2. Come si collega il dualismo storico *Gehirnpsychiatrie*/ *Geistespsychiatrie* (Lez. 02) con i quadri clinici trattati nelle lezioni successive?

La distinzione tra psichiatria "cerebrale" e psichiatria "dell'anima" attraversa tutto il corso. Le psicosi organiche (Lez. 09) appartengono al filone organicista: causa nota, io–qui–adesso crollato. Le psicosi funzionali e la schizofrenia sono multifattoriali e richiedono entrambi gli sguardi. Nevrosi (Lez. 07) e disturbi di personalità (Lez. 08) affondano le radici nel paradigma passionalista. Le sindromi affettive (Lez. 06) oscillano: le depressioni endogene verso il polo biologico, le psicogene verso quello passionale. I DCA (Lez. 11) confermano il pattern: vulnerabilità biologica + fattori psicologici e sociali; la cultura non causa il disturbo, ma ne modella la forma (fattore patoplastico, Jaspers).

3. Come si collegano i meccanismi di difesa (Lez. 04) con i tre grandi quadri strutturali — nevrosi, disturbi di personalità, psicosi?

I meccanismi di difesa sono il ponte tra la filiera emotiva e la struttura psicopatologica. Le difese primitive (diniego, scissione, proiezione, identificazione proiettiva) dominano nei disturbi di personalità di cluster A e B e nella struttura borderline e psicotica (Lez. 08, 09). Le difese mature/secondarie (rimozione, formazione reattiva, spostamento, isolamento) sono caratteristiche della struttura nevrotica (Lez. 07). Il tipo di angoscia prevalente orienta ulteriormente: angoscia di castrazione (nevrosi) · angoscia di abbandono (borderline) · angoscia di frammentazione (psicosi) — tutte introdotte in Lez. 04.

4. Qual è la differenza tra sintomo egodistonico ed egosintonico, e perché è clinicamente rilevante?

Il sintomo egodistonico è vissuto come estraneo all'io — il soggetto ne soffre, lo riconosce come problema e chiede aiuto: caratteristica della nevrosi (Lez. 07). Il sintomo egosintonico è vissuto come parte del sé — il soggetto non lo percepisce come problema; sono spesso gli altri a soffrirne: caratteristica dei disturbi di personalità (Lez. 08). La distinzione è cruciale per la motivazione al trattamento: il nevrotico chiede aiuto; il soggetto con disturbo di personalità spesso no, o viene portato da altri.

5. Come si collega il corpo alessitimico (Lez. 12) con i temi dell'empatia (Lez. 03), della regolazione affettiva (Lez. 04) e dei disturbi della nutrizione (Lez. 11)?

L'alessitimia è la difficoltà a dare parole alle emozioni — esattamente l'opposto di ciò che l'empatia matura richiede: percezione e decodifica degli stati emotivi altrui (Feshbach, Lez. 03). Chi non riesce a nominarle le proprie emozioni non può nemmeno riconoscerle nell'altro. Il legame con i DCA è diretto: nell'anoressia e nella bulimia il corpo diventa il linguaggio sostitutivo di una vita interiore non verbalizzabile (Lez. 11, 12). Le difese della Lez. 04 come l'isolamento degli affetti e la razionalizzazione sono i meccanismi che nei soggetti alessitimici diventano strutturali. Il congelamento affettivo di Krystal è la versione estrema di ciò che Freud chiama "disagio della civiltà" nella sua declinazione somatica.

6. Come si leggono i meccanismi di disimpegno morale (Lez. 13) alla luce dell'empatia (Lez. 03)?

I bias empatici di Pezzoli (Lez. 03) e i meccanismi di disimpegno morale di Bandura (Lez. 13) sono due facce dello stesso problema. I bias empatici mostrano perché faticosa empatizzare con chi è molto diverso, giudicato colpevole o vissuto come minaccioso. Il disimpegno morale mostra come si arrivi a fare del male — deumanizzando, diffondendo la responsabilità, attribuendo la colpa alla vittima — proprio attraverso la disattivazione del registro empatico. L'operatore che conosce entrambi i meccanismi può vigilare su sé stesso e sull'équipe. (Lez. 03, 13)

7. Come si integrano le lezioni sul corpo (Lez. 10–13) con il quadro clinico costruito nelle prime nove?

Le ultime quattro lezioni non sono appendici: sono la verifica sul campo di tutto ciò che è stato costruito prima. Il corpo sessuato (Lez. 10) mostra come il passaggio dal bisogno al desiderio — fallimento evolutivo che sta alla base delle parafilie — riecheggi la logica degli stadi di Hoffman (Lez. 03) e delle angosce primitive (Lez. 04). Il corpo deformato (Lez. 11) porta al centro la separazione-individuazione fallita, tema già presente nell'angoscia di abbandono del BPD (Lez. 08). Il corpo alessitimico (Lez. 12) radicalizza il concetto di deficit empatico e lo collega alle dipendenze. Il corpo violato (Lez. 13) chiude il cerchio: la violenza è la patologia della relazione, e la banalità del male di Arendt ricorda che l'insidia non è solo "là fuori" — abita anche chi lavora in aiuto. (Lez. 01–13)

8. Come descriveresti l'approccio complessivo di questo corso alla persona che soffre?

Il corso rifiuta la logica della catalogazione: non si tratta di imparare a etichettare i disturbi, ma di sviluppare la capacità di incontrare chi soffre. Questo richiede: capire la storia (Lez. 02) per non ripetere gli errori di chi ha ridotto la follia a malattia del cervello o a vizio morale; sviluppare empatia matura con consapevolezza dei suoi limiti (Lez. 03); saper leggere le emozioni e le difese (Lez. 04); osservare con rigore semiologico (Lez. 05); conoscere i quadri clinici senza ridurre la persona ad essi (Lez. 06–13). La distinzione tra *to cure* (guarire) e *to care* (curare) — introdotta fin dalla prima lezione — è la bussola: non tutto si può guarire, ma tutto può essere curato. (Lez. 01)